ROMA 난소암 위험도 검사, 확진이 아니라 "위험도를 가려주는" 검사입니다

이미 발견된 난소 혹이 암일 가능성이 높은 편인지 미리 가늠해, 처음부터 부인암 전문병원에서 진료받을지 정하는 데 쓰는 혈액검사입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

ROMA 검사, 세 가지만 기억하세요

암을 확정하는 검사가 아니라 '어디서 진료받을지'를 정하도록 돕는 검사입니다

1

위험도를 가늠하는 검사입니다

점수는 혹이 암일 가능성이 **높은 편인지 낮은 편인지**를 알려 줍니다. 암이라고 확정하지는 않습니다.

고위험이어도 양성 혹일 수 있고, 저위험이어도 추적이 필요할 수 있습니다.

확진은 수술·조직검사

2

이미 혹이 발견된 분이 받습니다

초음파 등에서 난소 혹이 보이고 수술을 앞둔 분이 대상입니다. 혹이 없는 분의 암 검진용이 아닙니다.

무증상 여성의 검진에 쓰도록 허가된 검사가 아닙니다.

대상: 난소 혹이 있는 분

3

목적은 알맞은 병원 찾기입니다

난소암은 처음부터 부인암 전문병원에서 수술받을 때 경과가 좋습니다. 점수가 높으면 그쪽으로 안내합니다.

그래서 점수는 '어디서 수술받을지'를 정하는 데 쓰입니다.

높으면 전문병원 안내

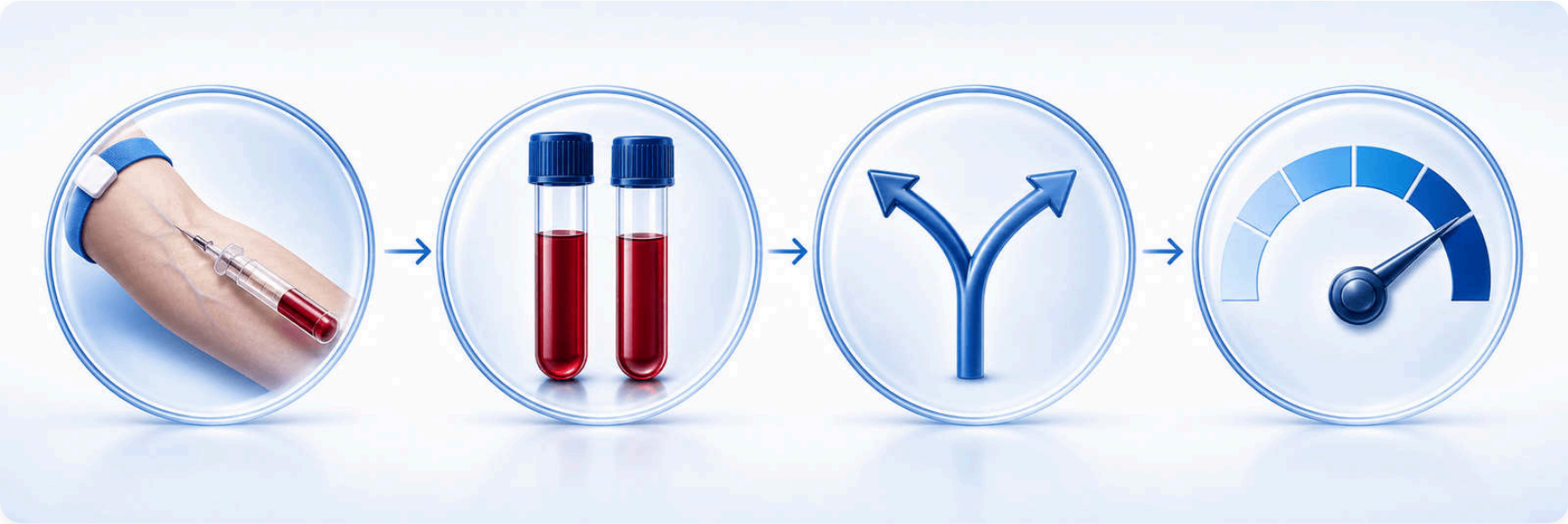
Tip · 점수 하나로 결정하지 않습니다. 초음파·CT 같은 영상과 진찰을 함께 봅니다.

근거 · Moore 2009 · ACOG 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

피 한 번으로 위험도 점수를 계산합니다

두 가지 혈액 표지자를 재고, 폐경 전·후에 따라 다른 계산식에 넣습니다



① 채혈 1회

팔에서 피를 한 번 뽑습니다 · 대개 금식 불필요

② 표지자 2가지

CA-125와 HE4 두 수치를 잽니다

③ 폐경 전·후

폐경 여부에 따라 다른 계산식을 씁니다

④ 위험도 점수

0~100% 점수로 높은 편·낮은 편을 나눕니다

Tip · 두 표지자는 서로의 약점을 보완합니다. 함께 볼 때 한 가지만 볼 때보다 구별이 좋아집니다.

근거 · Moore 2009 (Gynecol Oncol)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

CA-125와 HE4 — 약점이 서로 다릅니다

하나만으로는 부족해서 둘을 함께 봅니다

CA-125

가장 널리 쓰는 **난소암 표지자**입니다.

- 상피성 난소암의 80% 이상에서 올라갑니다
- 생리·임신·자궁내막증·근종·골반염에서도 오릅니다
- 그래서 폐경 전에는 **암이 아닌데 높게** 나오는 일이 많은 편입니다
- 혼자서는 양성·악성을 충분히 구별하지 못합니다

vs

HE4

CA-125를 **보완하는 표지자**입니다.

- 자궁내막증·근종 같은 양성 상태에서는 비교적 덜 오릅니다
- 콩팥 기능이 떨어졌거나 나이가 많거나 흡연하면 오를 수 있습니다
- 임신 중에는 오히려 낮아지는 경향이 있습니다
- 역시 혼자서는 진단하지 못해 CA-125와 함께 봅니다

Tip · 두 수치 모두 '오를 수 있는 다른 이유'가 있어 검사 전에 몸 상태를 알려 주시면 해석이 정확해집니다.

근거 · ACOG 2016 · Bolstad 2012

누가 · 어떻게 받는 검사인가요

이미 발견된 난소 혹의 성격을 가늠하기 위한 검사입니다

이런 분이 받습니다

난소 혹이 발견돼 수술이 계획된 만 18세 넘은 여성(폐경 전·후)으로, 아직 부인암 전문의에게 의뢰되지 않은 분입니다.

이런 용도는 아닙니다

증상도 혹도 없는 분의 **암 검진(스크리닝)**, 혼자서 암을 확정하는 일, 치료 뒤 재발을 지켜보는 일에는 쓰지 않습니다.

검사 방법

정맥에서 피를 한 번 뽑습니다. 대개 금식은 필요 없습니다. 두 수치와 폐경 상태로 점수를 계산합니다.

검사하는 이유

점수가 높은 편이면 처음부터 난소암을 전문으로 보는 병원에서 평가·수술받도록 안내하기 위해서입니다.

Tip · 검진 목적으로 받고 싶다면 이 검사보다 먼저 담당 의사와 어떤 검사가 맞는지 상의하세요.

근거 · 제조사 허가 사용 목적 · ACOG 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

기준값을 넘으면 '고위험'으로 분류합니다

기준값은 검사 장비·시약마다 다릅니다 — 검사한 곳의 기준을 따릅니다

검사 장비·시약	폐경 전 고위험	폐경 후 고위험	읽는 법
Roche(Cobas · Elecsys)	**11.4%** 이상	**29.9%** 이상	기준값 이상이면 고위험
Abbott(Architect)	약 **7.4%** 이상	약 **25.3%** 이상	장비마다 기준이 다름

폐경 전 기준이 더 낮은 이유

폐경 전에는 생리·자궁내막증 때문에 CA-125가 암이 아닌데도 오르는 일이 많아, 기준을 따로 잡습니다.

다른 병원 점수와 비교하지 마세요

장비·시약이 다르면 같은 숫자도 뜻이 달라집니다. 이전 결과가 있으면 어디서 검사했는지 함께 알려 주세요.

Tip · 점수는 영상·진찰과 함께 종합해 판단합니다.

근거 · Roche·Abbott 제조사 기준값

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

점수가 높으면 암인가요?

고위험이 곧 암은 아니고, 저위험이 100% 안심도 아닙니다

⚠ 고위험으로 나와도

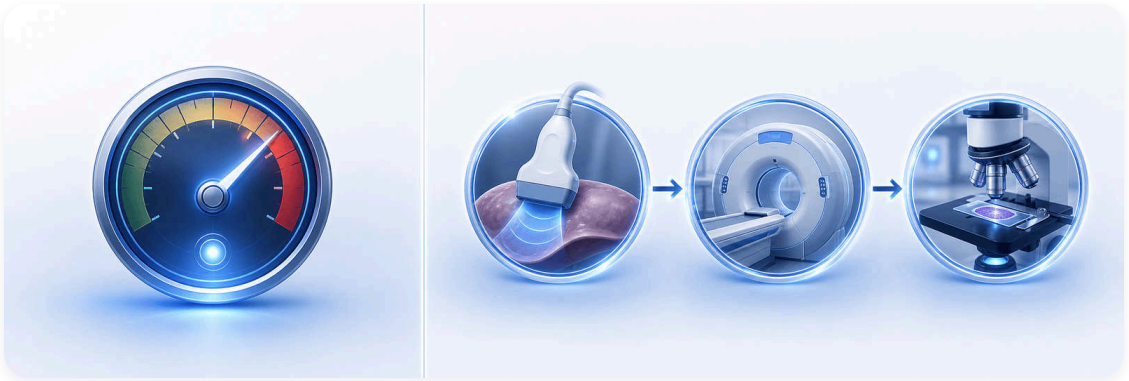
양성 혹이거나 다른 이유로 수치가 오른 **위양성**일 수 있습니다. 전문병원에서 영상·진찰로 더 자세히 봅니다.

저위험으로 나와도

실제 암을 놓치는 **위음성**이 있을 수 있습니다. 그래서 저위험이라고 추적을 그만두지 않습니다.

성능은 범위로 봅니다

연구마다 민감도 76~92%, 특이도 67~93%로 나타났습니다. 점수는 판단을 돕는 한 가지 자료입니다.



85.3%

민감도 — 암을 찾아내는 정도
(여러 연구를 합친 추정치)

82.4%

특이도 — 암이 아닌 것을 거르는 정도
(여러 연구를 합친 추정치)

Tip · 최종 진단은 수술로 떼어 낸 조직을 현미경으로 보는 조직검사로 확인합니다.

근거 · Wang 2014 메타분석(AAFP 2023 인용) · Moore 2009

암이 아닌데 수치가 오르는 경우

이런 상황에서는 점수가 높게 나올 수 있어 미리 알려 주시면 해석에 도움이 됩니다



검사 전에 알려 주세요

생리 주기와 임신 가능성, 자궁내막증·근종 같은 부인과 병력, 콩팥 질환, 흡연 여부를 말씀해 주세요.

생리 · 임신 초기
CA-125가 자연스럽게 오를 수 있습니다

자궁내막증 · 근종 · 선근증
자궁내막증은 보통 100 미만으로 오릅니다

골반 염증(골반염)
염증이 있으면 수치가 오를 수 있습니다

복막 · 흉막 자극
복부 수술 뒤·복막염·흉수 등

심부전 · 간경화 · 복수
암과 관계없이 수치가 오를 수 있습니다

콩팥 기능 저하 · 고령 · 흡연
HE4가 오를 수 있습니다

Tip · 이런 이유가 있으면 담당 의사가 점수를 더 조심스럽게 해석합니다.

근거 · ACOG 2016 · Bolstad 2012

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고위험으로 나오면 이렇게 진행합니다

'전문병원에서 볼지' 정하는 신호입니다 — 이 순서로 진행합니다

① 부인암 전문의에게 의뢰

가능성이 높은 편이면 난소암을 전문으로 보는 병원에서 평가·수술받도록 안내합니다.

② 추가 영상·진찰

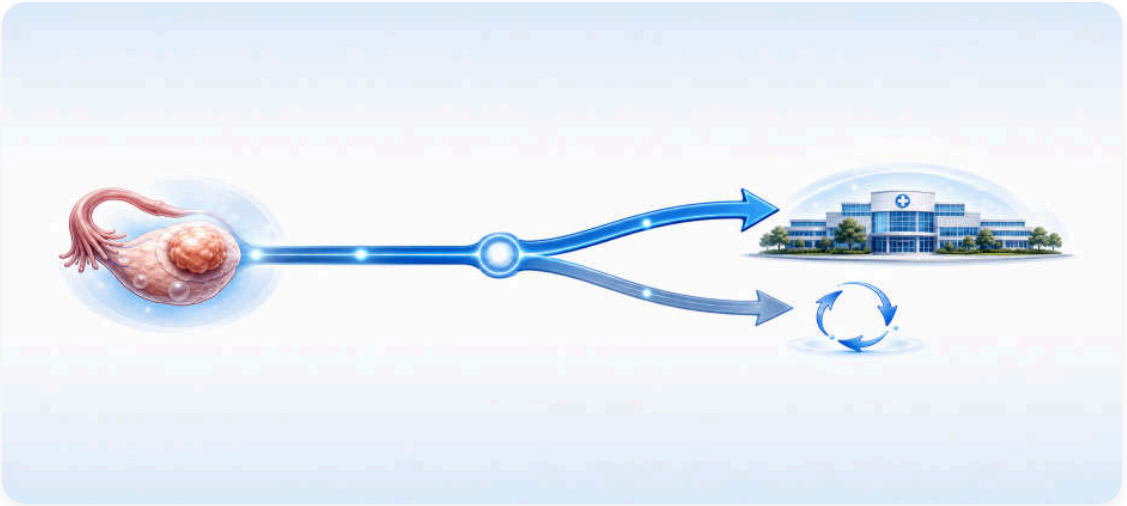
정밀 초음파·CT·MRI로 혹의 성질을 더 자세히 봅니다.

③ 필요하면 수술·조직검사

최종 진단은 수술과 조직검사로 확인합니다.

저위험이어도 추적합니다

증상과 영상 소견에 따라 추적 관찰이나 추가 검사를 합니다.



점수만으로 암을 확정하지 않습니다 — 영상·진찰·조직검사가 함께 갑니다

Tip · 저위험 결과를 받았어도 증상이 새로 생기거나 심해지면 진료를 받으세요.

근거 · ACOG 2016 · Moore 2009

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

검사부터 결과 설명까지 네 단계

검사 전에 알릴 것과 결과를 들을 때 기억할 것을 순서대로 모았습니다

1 알리기

임신 가능성·생리 주기, 자궁내막증·근종 병력, 콩팥 질환, 흡연 여부를 먼저 말씀해 주세요.

수치를 올리는 이유 미리 확인

2 채혈

팔에서 피를 한 번 뽑습니다. 대개 금식은 필요 없습니다.

대개 금식 불필요

3 점수 계산

두 수치와 폐경 상태로 점수를 내고, 검사한 곳의 기준값으로 높은 편·낮은 편을 나눕니다.

기준값은 장비·시약마다 다름

4 결과 설명

점수만이 아니라 영상·진찰 소견과 함께 설명을 듣고 다음 단계를 정합니다.

영상·진찰과 함께 판단

다른 병원의 점수와 단순 비교하지 않고, 수치 하나로 결론 내리지 않습니다

Tip · 궁금한 점은 결과를 들을 때 바로 물어보세요.

근거 · Moore 2009 · 제조사 사용 설명

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

ROMA 검사를 한 장으로 정리하면

무엇을 · 누가 · 어떻게 · 결과 뒤에 무엇을 하는지

질문	답
무엇인가요	난소 혹이 암일 가능성이 **높은 편인지** 가늠하는 혈액검사입니다
누가 받나요	난소 혹이 발견돼 수술이 계획됐고, 아직 부인암 전문의에게 의뢰되지 않은 만 18세 넘은 여성
어떻게 하나요	채혈 1회 → 두 표지자 + 폐경 상태로 점수 계산
결과는	기준값 이상이면 고위험 · 기준값은 장비·시약마다 다름
그다음은	고위험이면 전문병원 의뢰와 추가 영상 · 저위험이어도 필요하면 추적

Tip · 최종 진단은 수술과 조직검사로 확인합니다.

근거 · Moore 2009 · ACOG 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

난소 혹이 발견돼 ROMA 검사를 앞둔 분을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료 결정은 담당 의료진과 상의해 정합니다.

참고한 자료

Moore RG 등, Gynecol Oncol 2009(ROMA 개발) · ACOG Practice Bulletin 174(2016, 부속기 종괴) · Wang 등 2014 메타분석(AAFP 2023 인용) · Bolstad 2012(HE4 기준치) · Roche·Abbott 제조사 기준값

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요